

1. La vascularisation de l'intestin grêle et du côlon est assurée uniquement par le tronc coeliaque.	1. Faux
2. L'arcade de Riolan est une anastomose entre le tronc coeliaque et l'artère mésentérique supérieure.	2. Faux
3. Les variations anatomiques des troncs viscéraux sont rares.	3. Faux
4. Les lésions sténosantes des troncs viscéraux sont généralement d'origine athéroscléreuse (>95% des cas).	4. Vrai
5. La dysplasie fibromusculaire est une étiologie fréquente des lésions sténosantes des troncs viscéraux.	5. Faux
6. La plupart des sténoses des troncs viscéraux sont asymptomatiques grâce aux nombreuses suppléances.	6. Vrai
7. Les patients atteints de sténoses serrées sur au moins 2 des 3 troncs viscéraux peuvent présenter des manifestations cliniques d'ischémie mésentérique chronique.	7. Vrai
8. L'échographie-Doppler est l'examen de référence pour diagnostiquer les sténoses des troncs viscéraux.	8. Faux
9. L'angiographie conventionnelle est utilisé comme examen de dépistage des sténoses des troncs viscéraux.	9. Faux
10. Le traitement chirurgical est toujours préféré au traitement endoluminal pour les lésions sténosantes des troncs viscéraux.	10. Faux
11. Le traitement des sténoses des troncs viscéraux visent à prévenir la récurrence des symptômes et l'ischémie.	11. Vrai

12. Les patients atteints de lésions sténosantes des troncs viscéraux doivent recevoir une anticoagulation.	12. Faux
13. Les douleurs abdominales après le repas sont un symptôme courant de l'ischémie mésentérique chronique.	13. Vrai
14. La sitophobie est une crainte vis-à-vis de l'alimentation observée en cas d'ischémie mésentérique chronique.	14. Vrai
15. Le souffle systolique épigastrique est étendu à l'auscultation en cas d'ischémie mésentérique chronique.	15. Vrai
16. Les lésions sténosantes des troncs viscéraux surviennent généralement chez les moins de 50 ans.	16. Faux
17. La thrombose veineuse mésentérique est une cause d'ischémie mésentérique aiguë.	17. Vrai
18. Des lésions cellulaires irréversibles surviennent après 2h en cas d'ischémie mésentérique totale et aiguë.	18. Faux
19. L'ischémie mésentérique aiguë entraîne d'abord des lésions muqueuses avec une nécrose de l'épithélium.	19. Vrai
20. Les embolies dans l'artère mésentérique inférieure sont une cause fréquente d'occlusion artérielle aiguë.	20. Faux
21. Les patients atteints d'ischémie mésentérique aiguë peuvent présenter des douleurs abdominales violentes et d'emblée continues, généralement localisées dans la région épigastrique.	21. Faux
22. L'examen clinique est souvent riche en informations au stade précoce de l'ischémie mésentérique aiguë.	22. Faux
23. La leucocytose est un signe biologique précoce de l'ischémie mésentérique aiguë.	23. Vrai
24. La distension des anses intestinales est un signe d'ischémie mésentérique aiguë à la tomодensitométrie.	24. Vrai
25. L'héparinothérapie est le traitement de choix pour l'ischémie occlusive mésentérique aiguë.	25. Vrai

26. La thrombose veineuse mésentérique est toujours secondaire à une maladie inflammatoire ou néoplasique.	26. Faux
27. La sigmoïdoscopie avec insufflation est recommandée pour le diagnostic de la colite ischémique.	27. Faux
28. Le traitement chirurgical est souvent nécessaire dans la colite ischémique pour prévenir les complications.	28. Faux
29. L'angio-scanner permet de visualiser les calcifications volumineuses dans les sténoses des troncs viscéraux.	29. Faux
30. L'angio-scanner a tendance à surestimer les sténoses serrés lors de l'examen des artères.	30. Faux
31. Le traitement médicamenteux des lésions sténosantes des troncs viscéraux comprend des antiagrégants.	31. Vrai
32. Les douleurs abdominales après le repas sont un symptôme spécifique de l'ischémie mésentérique aiguë.	32. Faux
33. Les patients atteints de colite ischémique sont généralement jeunes et en bonne santé.	33. Faux
34. La colite ischémique est la 2 ^{ème} cause d'hémorragie digestive basse.	34. Vrai
35. Le traitement chirurgical est souvent nécessaire en cas de thrombose veineuse mésentérique.	35. Faux
36. L'ischémie mésentérique aiguë se manifeste par une alcalose métabolique et une élévation des LDH.	36. Faux
37. La tomодensitométrie montre un épaissement de la paroi veineuse en cas d'ischémie mésentérique aiguë.	37. Faux
38. L'antibiothérapie à large spectre est souvent utilisée dans le traitement de la colite ischémique.	38. Vrai
39. Les thromboses veineuses mésentériques primaires sont souvent associées à des anomalies de l'hémostase.	39. Vrai
40. L'administration prolongée de catécholamines favorise l'ischémie mésentérique non-occlusive.	40. Vrai

41. Les patients atteints d'ischémie mésentérique aiguë peuvent présenter une hypotension et un choc.	41. Vrai
42. Les thromboses veineuses mésentériques peuvent être visualisées par CT-scanner.	42. Vrai
43. L'anticoagulation est généralement utilisée dans le traitement des thromboses veineuses mésentériques.	43. Vrai
44. Les patients atteints d'ischémie mésentérique aiguë peuvent présenter une diarrhée et du méléna.	44. Vrai
45. Les thromboses veineuses mésentériques sont rarement associées à des néoplasies.	45. Faux
46. La prévention cardiovasculaire est importante dans le traitement des lésions sténosantes des troncs viscéraux.	46. Vrai
47. La leucocytose est un signe tardif de l'ischémie mésentérique aiguë.	47. Faux
48. La tomодensitométrie sans contraste est généralement utilisée pour le diagnostic de la colite ischémique.	48. Faux
49. La sigmoïdoscopie avec insufflation risque de déchirer la séreuse en cas de colite ischémique.	49. Vrai
50. Les patients atteints d'ischémie mésentérique aiguë ne présentent jamais de nausées.	50. Faux
51. Les thromboses veineuses mésentériques peuvent être associées à des pancréatites aiguës.	51. Vrai
52. L'ischémie mésentérique aiguë non-occlusive est due à une vasoconstriction mésentérique disproportionnée.	52. Vrai
53. La tomодensitométrie est l'examen de choix pour voir les embolies en cas d'ischémie mésentérique aiguë.	53. Faux
54. Le ballonnement abdominal est un symptôme des thromboses veineuses mésentériques.	54. Vrai
55. Les thromboses veineuses mésentériques peuvent être associées à la cirrhose ou l'hypertension portale.	55. Vrai

56. Les thromboses veineuses mésentériques peuvent être associées à la contraception orale.	56. Vrai
57. La colite ischémique atteint le plus souvent le colon ascendant et le colon sigmoïde.	57. Faux
58. Il existe des anastomoses entre l'artère mésentérique supérieure et les artères hypogastriques.	58. Faux
59. Il existe des anastomoses entre le tronc coeliaque et l'artère mésentérique supérieure.	59. Vrai
60. Les lésions sténosantes des troncs viscéraux siègent le plus souvent à l'ostium ou sur les 1 ^{ers} cm du vaisseau.	60. Vrai
61. La maladie de Takotsubo est une cause très rare de lésions sténosantes des troncs viscéraux.	61. Faux
62. La plupart des lésions sténosantes des troncs viscéraux sont rapidement symptomatiques.	62. Faux
63. Une sténose serrée sur 1 des 3 troncs suffit à provoquer des symptômes d'ischémie mésentérique chronique.	63. Faux
64. Les patients atteints de sténoses des troncs viscéraux ont souvent d'autres atteintes athéroscléreuses.	64. Vrai
65. Des douleurs abdominales surviennent souvent précocement dans les 15-30 minutes après le repas en cas d'ischémie mésentérique chronique.	65. Vrai
66. L'ischémie mésentérique chronique entraîne très souvent une prise de poids.	66. Faux
67. L'écho-Doppler ne permet pas de visualiser correctement les sténoses des troncs viscéraux chez l'obèse.	67. Vrai
68. L'angiographie par résonance magnétique est un examen très précis pour les sténoses des troncs viscéraux.	68. Faux
69. L'angiographie conventionnelle nécessite l'injection d'un produit de contraste.	69. Vrai

70. L'angiographie conventionnelle ne permet qu'une analyse segmentaire de la vascularisation.	70. Faux
71. L'angiographie conventionnelle (face et profil) est l'examen de référence pour visualiser les sténoses des troncs viscéraux.	71. Vrai
72. L'aspirine ou le clopidogrel sont utilisés dans le traitement des lésions sténosantes des troncs viscéraux.	72. Vrai
73. Les lésions asymptomatiques étendues des troncs viscéraux sont une indication de traitement.	73. Faux
74. Le traitement chirurgical consiste en un pontage par greffe veineuse ou une réimplantation aortique en cas d'ischémie mésentérique chronique symptomatique	74. Vrai
75. Le traitement endoluminal est la technique de référence pour traiter les ischémies mésentériques chroniques.	75. Faux
76. L'occlusion veineuse est responsable de la majorité des cas d'ischémie mésentérique aigue.	76. Faux
77. L'ischémie mésentérique aigue peut être due à une cause extravasculaire : volvulus, hernie étranglée,...	77. Vrai
78. Les lésions cellulaires irréversibles surviennent après 4h d'ischémie mésentérique aigue totale.	78. Vrai
79. L'ischémie non-occlusive est responsable d'environ 10% des cas d'ischémie mésentérique aigue.	79. Faux
80. L'occlusion artérielle aigue est responsable d'environ 50-70% des cas d'ischémie mésentérique aigue.	80. Vrai
81. L'occlusion veineuse est responsable d'environ 20% des cas d'ischémie mésentérique aigue.	81. Faux
82. L'ischémie mésentérique aigue atteint d'abord la séreuse et la musculieuse.	82. Faux

83. Les embolies responsables d'une occlusion aiguë de l'AMS sont le plus souvent d'origine cardiaque.	83. Vrai
84. Les embolies de microcristaux de cholestérol sont souvent trop petits pour occlure un tronc viscéral.	84. Faux
85. L'atteinte de la musculature peut entraîner un infarctus transmural, une perforation intestinale et une péritonite en cas d'ischémie mésentérique aiguë.	85. Vrai
86. L'occlusion artérielle aiguë peut être causée par une thrombose in situ sur une sténose athéroscléreuse.	86. Vrai
87. L'extension des lésions à la sous-muqueuse entraîne un œdème et des hémorragies de la paroi intestinale en cas d'ischémie mésentérique aiguë.	87. Vrai
88. La dissection aortique n'entraîne jamais d'occlusion artérielle mésentérique aiguë.	88. Faux
89. Les traumatismes, les vasculites, la dysplasie fibromusculaire et la thrombocytose sont des causes plus rares d'ischémie mésentérique aiguë par occlusion veineuse aiguë.	89. Faux
90. L'ischémie mésentérique aiguë provoque des douleurs abdominales violentes et crampoïdes.	90. Vrai
91. L'ischémie mésentérique aiguë est parfois paucisymptomatique chez le sujet âgé.	91. Vrai
92. L'ischémie mésentérique aiguë entraîne une douleur péri-ombilicale irradiée dans la fosse iliaque gauche.	92. Faux
93. L'examen clinique révèle une légère sensibilité abdominale et une douleur qui semble disproportionnée au stade précoce d'une ischémie mésentérique aiguë.	93. Vrai

94. L'RM montre un embole avec un aspect caractéristique en cupule concave en cas d'occlusion artérielle mésentérique aigue.	94. Faux
95. La résection intestinale est toujours nécessaire en cas d'ischémie mésentérique aigue.	95. Faux
96. Le traitement de l'ischémie mésentérique aigue vise à rétablir la circulation mésentérique et à lever l'ischémie.	96. Vrai
97. L'embolectomie et la revascularisation par endoprothèse sont des options de traitement pour les occlusions artérielles mésentériques aiguës causées par une thrombose in situ sur sténose athéromateuse.	97. Faux
98. L'hypotension, le choc et le bas débit cardiaque favorisent les ischémies mésentériques non-occlusives.	98. Vrai
99. L'artériographie montre une image « d'arbre mort » en cas d'ischémie mésentérique non-occlusive.	99. Vrai
100. La tomodensitométrie est l'examen de choix pour repérer une ischémie mésentérique non-occlusive.	100. Faux
101. Le traitement des ischémies mésentériques aiguës non-occlusives comprend des vasodilatateurs administrés par le cathéter d'artériographie et des anticoagulants.	101. Vrai
102. La splénectomie ou le contexte post-opératoire favorisent les thromboses veineuses mésentériques.	102. Vrai
103. La douleur abdominale est plus souvent subaigue en cas de thrombose veineuse mésentérique.	103. Vrai
104. La colite ischémique représente 90% des ischémies digestives.	104. Faux
105. La colite ischémique est l'atteinte vasculaire digestive la plus fréquente.	105. Vrai

106.	La colite ischémique a une étiologie multifactorielle associée à l'HTA, le diabète et les pathologies CV.	106. Vrai
107.	L'incidence de la colite ischémique est en diminution dans la population générale.	107. Faux
108.	La colite ischémique est toujours due à une cause occlusive des artères mésentériques.	108. Faux
109.	Les causes non-occlusives de colite ischémique sont nombreuses : choc (hypovolémique, septique, cardiogénique, anaphylactique), cocaïne, effort physique intense et prolongé, IC, déshydratation,...	109. Vrai
110.	Une vasodilatation soudaine peut entraîner une colite ischémique.	110. Faux
111.	L'angle splénique et le sigmoïde sont les 2 zones du colon les plus sensibles à l'ischémie.	111. Vrai
112.	L'aortographie peut entraîner des thromboses ou des embolies des artères mésentériques.	112. Vrai
113.	Une obstruction colique par un cancer ou un fécalome peut provoquer une colite ischémique.	113. Vrai
114.	La drépanocytose n'est jamais une cause de colite ischémique occlusive.	114. Faux
115.	Le sepsis intra-abdominal, la cirrhose et la pancréatite aiguë sont des causes de colite ischémique.	115. Vrai
116.	La colite ischémique peut être provoquée par des syndromes myéloprolifératifs ou une CIVD.	116. Vrai
117.	La colite ischémique entraîne des douleurs abdominales sévères dans le flanc et la fosse iliaque gauche.	117. Faux
118.	La colite ischémique peut entraîner des rectorragies, des diarrhées sanglantes ou une péritonite.	118. Vrai
119.	La présence d'un ulcère colique hémorragique n'est pas une contre-indication aux anticoagulants.	119. Faux

120. Les antiagrégants plaquettaires ne sont pas nécessaires dans le traitement de la colite ischémique.	120. Faux
121. Le traitement chirurgical est réservé aux colites ischémiques compliquées (péritonite, hémorragies,...).	121. Vrai
122. Le traitement endovasculaire est inutile en cas de colite ischémique.	122. Faux
123. La sténose symptomatique secondaire à une colite ischémique est une indication chirurgicale.	123. Vrai
124. La chirurgie est recommandé en cas d'échec du traitement médical pour les colites ischémiques.	124. Vrai
125. Une antibiothérapie à large spectre est administrée dans tous les cas de colites ischémiques.	125. Faux
126. La tomodensitométrie avec injection de produit de contraste permet de faire le diagnostic différentiel de la colite ischémique et d'observer les vaisseaux mésentériques.	126. Vrai